

首次病程记录

2020-12-23 14:19

患者姓名：官茜 性别：女 年龄：31岁

一、病例特点：1.患者，官茜，31岁，女，未婚。2.主诉：宫腔镜术后9天。患者2020-12-13因无明显诱因阴道不规则出血9天于我院就诊，妇科彩超提示：子宫肌瘤，2020-12-14行宫腔镜诊刮治疗，术后病检提示：子宫内膜息肉。患者平素月经规则，6/28天，量中，色暗红，无痛经史，末次月经2020-11-25。现患者一般情况可，无阴道出血、腹痛、腹胀等不适，为求进一步诊治，门诊以“子宫平滑肌瘤、宫腔镜术后”收住院。3.既往：2020-12-14行宫腔镜诊刮术，否认结核、艾滋、梅毒病史，无高血压、心脏病、糖尿病等病史无外伤史，无输血史，黄连素、芒果过敏。4.体检：T 36.5℃，P 78次/分，R 20次/分，BP 100/65mmHg，神志清楚，查体合作，双肺呼吸音清晰，未闻及干湿罗音，心率79次/分，律齐，心音正常，各瓣膜听诊区未闻及明显杂音，腹平软，无压痛及反跳痛，双肾区无叩痛，肠鸣音正常，双下肢不肿。5.专科检查：外阴已婚型，阴道畅，少许淡红色分泌物；宫颈光滑；子宫常大；双侧附件未见明显异常。6.辅助检查：我院出院小结一份

二、诊断：子宫平滑肌瘤

异常子宫出血

宫腔镜检查 术后

诊断依据：1.患者，官茜，31岁，女，未婚。2.主诉：宫腔镜术后9天。3.既往：2020-12-14行宫腔镜诊刮术，否认结核、艾滋、梅毒病史，无高血压、心脏病、糖尿病等病史无外伤史，无输血史，黄连素、芒果过敏。4.体检：T 36.5℃，P 78次/分，R 20次/分，BP 100/65mmHg，神志清楚，查体合作，双肺呼吸音清晰，未闻及干湿罗音，心率79次/分，律齐，心音正常，各瓣膜听诊区未闻及明显杂音，腹平软，无压痛及反跳痛，双肾区无叩痛，肠鸣音正常，双下肢不肿。5.专科检查：外阴已婚型，阴道畅，少许淡红色分泌物；宫颈光滑；子宫常大；双侧附件未见明显异常。6.辅助检查：我院出院小结一份

三、拟诊讨论

鉴别诊断：子宫肌瘤主要与妊娠子宫，卵巢肿瘤，子宫腺肌症等相鉴别，血尿HCG，B超有助于诊断

鉴别诊断依据：妊娠子宫：妊娠有停经史，早孕反应，子宫随停经月份增大变软；卵巢肿瘤：多无月经改变，呈囊性位于子宫一侧；子宫腺肌症痛经症状与异位症相似，但通常更严重，疼痛位于下腹正中，妇科检查子宫多为均匀性增大，呈球形，质硬，经期检查子宫触痛明显。通过临床症状及妇科检查及B超可鉴别

四、诊疗计划

检查计划：完善相关检查：血常规、尿常规、肝肾功能、凝血象等

治疗措施：1.完善相关检查；2.向上级医师汇报病情指导治疗 3.择期手术

住

住院医师

廖芳 姚时婕

2020-12-24 08:51

张蔚 主任医师查房记录

对患者的病情分析：1.患者，官茜，31岁，女，未婚。2.主诉：宫腔镜术后9天。患者2020-12-13因无明显诱因阴道不规则出血9天于我院就诊，妇科彩超提示：

武汉大学中南医院

病程记录

姓名： 官茜

住院号： 0001485677

子宫肌瘤，2020-12-14行宫腔镜诊刮治疗，术后病检提示：子宫内膜息肉。患者平素月经规则，6/28天，量中，色暗红，无痛经史，末次月经2020-11-25。现患者一般情况可，无阴道出血、腹痛、腹胀等不适，为求进一步诊治，门诊以“子宫平滑肌瘤、宫腔镜术后”收住院。3.既往：2020-12-14行宫腔镜诊刮术，否认结核、艾滋、梅毒病史，无高血压、心脏病、糖尿病等病史无外伤史，无输血史，黄连素、芒果过敏。4.体检：T 36.5℃，P 78次/分，R 20次/分，BP 100/65mmHg，神志清楚，查体合作，双肺呼吸音清晰，未闻及干湿罗音，心率79次/分，律齐，心音正常，各瓣膜听诊区未闻及明显杂音，腹平软，无压痛及反跳痛，双肾区无叩痛，肠鸣音正常，双下肢不肿。5.专科检查：外阴已婚型，阴道畅，少许淡红色分泌物；宫颈光滑；子宫常大；双侧附件未见明显异常。6.辅助检查：我院出院小结一份。入院查白带常规分析[2020-12-23 17:21:16]：红细胞：阳性(++)；上皮细胞：阳性(++++);MRI：盆腔平扫+增强【2020-12-24 14:52:39】：子宫后壁肌瘤；宫颈小囊肿；盆腔少许积液。查血常规、肝肾功能、凝血功能、甲功等均无明显异常。张蔚主任查房示：患者目前诊断：子宫平滑肌瘤，异常子宫出血，宫腔镜检查 拟明日手术治疗。

诊疗意见：根据入院检查无明显手术禁忌，与患者及家属交代病情，患者及家属理解并同意手术治疗。拟明日行经腹子宫肌瘤剔除术。病变性质待术后病检回报。

主治医师

易耿雄

主任医师

张蔚

术后首次病程记录

2020-12-25 14:24

手术时间：2020-12-25 14:24

目标部位：盆腔

诊断依据：根据临床表现及辅助检查

术中诊断：子宫平滑肌瘤

右侧 卵巢巧克力样囊肿

子宫腺肌瘤

异常子宫出血

宫腔镜检查 术后

麻醉方式：全麻

手术方式：子宫肌瘤切除术(+子宫成形术)+卵巢病损切除术+卵巢成形术

手术简要经过：1、全麻成功后，病人取膀胱截石位，上至乳头连线，下至大腿上1/3，两侧至腋中线，外阴消毒，铺无菌巾。

2、耻骨上两横指下腹部一长约7cm的手术瘢痕逐层进入腹腔。

3、探查见：子宫形态失常，子宫后壁可见一大小约6×6×7cm肌壁间子宫肌瘤，边界清，质硬，子宫左侧壁突起病灶，与周围子宫肌层分界欠清，范围约2×1cm，质脆，子宫表面可见多发0.2×0.2cm大小的腺肌瘤，右侧卵巢可见一大小约1.5×3.5cm的囊性包块，表面光滑，内见巧克力样囊液，右侧输卵管未见异常。

4、排垫肠管，暴露子宫，子宫肌层注射垂体针1支。于子宫后壁肌瘤体处切开肌层，瘤体边界清，锐性剥离瘤体。剥除子宫左侧壁突起病灶，子宫表面多发腺肌瘤依次

武汉大学中南医院

病程记录

姓名：官茜

住院号：0001485677

电凝，电凝止血，子宫创面棒球法缝合，恢复子宫解剖形态。钝锐性分离右侧卵巢皮质与囊肿间隙，见巧克力样囊液流出，完整剥除卵巢囊肿，缝合卵巢，恢复卵巢解剖结构。

5、检查左侧附件区未见异常。

6、术后检查创面无出血，冲洗腹腔，未见渗血。清点纱布、器械如数，留置腹腔引流管一根，逐层缝合腹部切口。

7、手术顺利，麻醉效果好，患者生命体征稳定，术中出血约 200ml，尿液 200ml，色清。术毕麻醉复苏后安返病房。离体标本送家属过目后送病理检查。

术后处理措施：给予抗感染、促宫缩、止血、护胃、止吐及补液治疗。

术后注意观察事项：关注患者生命体征、阴道出血量、腹腔引流量、尿量及伤口愈合情况等。

住院医师

廖菁

2020-12-26 08:09

张蔚 主任医师查房记录

对患者的病情分析：对患者的病情分析：今为患者术后第1天，患者一般情况好，无发热，无腹痛，无腹胀，无阴道出血等特殊不适，肛门未排气，查体生命体征平稳，全腹柔软，腹部切口外敷料干燥，无渗血渗液，腹腔引流管通畅，引流出少许淡红色血性液体，尿管通畅，尿色清亮，尿量可。今日复查血常规分析[2020-12-26 09:24:35]：红细胞： $3.14 \times 10^{12}/L \downarrow$ ；血红蛋白：93.0g/L $\downarrow$ ；中性粒细胞绝对值： $7.50 \times 10^9/L \uparrow$ ；CGYB 肝肾糖电解质（黄管 3ml）[2020-12-26 09:30:54]：总蛋白（TP）：53.4g/L $\downarrow$ ；白蛋白（ALB）：28.9g/L $\downarrow$ ；张蔚主任医师查房后示：患者目前情况可，病情评估如下：风险因素：出血、感染可能；预后：手术效果可；评估等级：现患者生命体征平稳，病情一般；护理等级由一级护理改为二级护理；嘱患者可少量饮水，待通气后可过渡到流食至半流食，多下床活动，避免下肢血栓形成，今继续预防感染、补液、营养对症支持治疗，密切观察患者病情。

诊疗意见：1.继续抗感染、营养、补液对症支持治疗；2.嘱患者多下床活动，避免血栓形成；3.今日打完针后拔尿管。

主治医师

廖菁

主任医师

张蔚

2020-12-27 10:52

易跃雄 主治医师查房记录

患者术后第2天，一般情况好，未诉特殊不适，肛门已排气，未排便，无发热，无腹痛，无腹胀，无阴道出血等特殊不适，查体生命体征平稳，腹部切口外敷料干燥，无渗血渗液，腹部引流管通畅，引流出少许血性液体，尿管已拔除，小便已自解。嘱患者可少量多次进流食，多下床活动，今日停止止血、护胃药物，继续预防感染治疗，密切关注患者病情。

诊疗意见：1.继续预防感染对症支持治疗；2.嘱患者可少量多次进流食，多下床活动；3.打完针后拔除腹腔引流管。

武汉大学中南医院

病程记录

姓名：官茜

住院号：0001485677

住院医师

廖葳

主治医师

易耿雄

2020-12-28 10:59

今为患者术后第3天，一般情况可，未诉特殊不适，无发热，无腹胀，无阴道出血，查体生命体征平稳，全腹柔软，腹部切口外敷料干燥，无渗血渗液，腹腔引流管已拔除，尿管已拔除，小便自解，尿量可，继续预防感染治疗，密切关注患者基本生命体征及伤口愈合情况。

住院医师

廖葳

2020-12-29 08:57

张蔚 主任医师查房记录

对患者的病情分析：患者术后第4天，阴道少量出血，未诉发热、下腹痛等不适，大小便正常。查体：生命体征平稳，腹部切口愈合好。复查血常规分析[2020-12-29 08:42:00]：血红蛋白：95.0g/L↓；[2020-12-29 10:15:42]：D-二聚体：1271ng/ml↑；肝肾功能未见明显异常；张蔚主任医师查房后示：患者一般情况可，告知相关出院注意事项，拟于今日出院。

诊疗意见：患者一般情况可，告知相关出院注意事项，拟于今日出院。

主治医师

易耿雄

主任医师

张蔚

2020-12-29 11:37

出院前记录

简要病史和患者现生命体征、阳性辅助检查、诊疗过程：

1.患者，官茜，31岁，女，未婚。2.主诉：宫腔镜术后9天。3.既往：2020-12-14行宫腔镜诊刮术，否认结核、艾滋、梅毒病史，无高血压、心脏病，糖尿病等病史无外伤史，无输血史，黄连素、芒果过敏。4.体检：T 36.5℃，P 78次/分，R 20次/分，BP 100/65mmHg，神志清楚，查体合作，双肺呼吸音清晰，未闻及干湿罗音，心率79次/分，律齐，心音正常，各瓣膜听诊区未闻及明显杂音，腹平软，无压痛及反跳痛，双肾区无叩痛，肠鸣音正常，双下肢不肿。5.专科检查：外阴已婚型，阴道畅，少许淡红色分泌物；宫颈光滑；子宫常大；双侧附件未见明显异常。6.辅助检查：我院出院小结一份。入院查白带常规分析[2020-12-23 17:21:16]：清洁度：III度；血常规分析[2020-12-23 16:41:29]：血红蛋白：106.0g/L↓；[2020-12-23 16:52:21]：D-二聚体：542ng/ml↑；血型+不规则抗体筛查[2020-12-24 15:06:12]：ABO血型（正反定型）：O型；RhD血型：阳性；细菌培养、肝肾功能未见明显异常，MRI：盆腔平扫+增强【2020-12-24 14:52:39】：子宫后壁肌瘤；宫颈小囊肿；盆腔少许积液。完善相关检查，无手术禁忌症，于2020.12.25行全麻下经腹子宫肌瘤切除术（+子宫成形术）+子宫腺肌瘤剔除术+右侧卵巢囊肿切除术+卵巢成形术，术后予以抗感染、促宫缩、止血、护胃、止吐及补液治疗，术后复查血常规分析[2020-12-26 09:24:35]：血红蛋白：93.0g/L↓；中性粒细胞百分比：80.4%↑；[2020-12-26 09:15:26]：D-二聚体：945ng/ml↑；CGYB肝肾糖电解质[2020-12-26 09:30:54]：天冬氨

武汉大学中南医院

病程记录

姓名：官茜

住院号：0001485677

酸氨基转移酶: 12U/L↓; 尿素 (UREA): 2.51mmol/L↓; 现患者一般情况可, 无腹痛、阴道出血等不适, 今日复查血常规分析[2020-12-29 08:42:00]: 血红蛋白: 95.0g/L↓; 凝血及肝肾功能无明显异常。现患者及家属要求出院, 报告上级医师, 予以办理。

出院诊断：子宫平滑肌瘤; 子宫腺肌瘤; 右侧 卵巢巧克力样囊肿; 异常子宫出血; 宫腔镜检查 术后; 轻度贫血

上级医师意见 患者现生命体征平稳, 状态可, 经上级医生同意, 今日可以出院。

住院医师

廖菁